

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE CAMBIOS EN LA FUNCIÓN SEXUAL (CSFQ-14)

Eje VI: Conducta de Salud y Sexualidad • Evaluación Multidimensional de Anita Clayton

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Cambios en la Función Sexual (CSFQ-14; versión reducida).
Nombre Original	Changes in Sexual Functioning Questionnaire - Short Form (CSFQ-14; Clayton et al., 1997; Keller et al., 2006).
Autores Originales	Anita H. Clayton, M.D., Elizabeth L. McGarvey, Ph.D. y G. J. Clavet (University of Virginia).
Adaptaciones Hispanas	Bobes et al. (2000); Montejo et al.; validación en España por el Grupo de Trabajo de Psiquiatría.
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Somática y Sexualidad. Funcionamiento sexual integral en 5 dimensiones clínicas.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme estructurado (versiones diferenciadas para hombres y mujeres).
Composición de Ítems	14 reactivos evaluados en escala Likert de 5 opciones (1 a 5; rango 14 a 70 puntos).
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años); cribado y monitorización en depresión, ansiedad y farmacoterapia.
Tiempo de Administración	5 a 7 minutos de cumplimentación autónoma con instrucciones claras.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y de investigación médica con atribución autoral.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO INTEGRAL DE FASES SEXUALES

El **CSFQ-14** fue desarrollado para ofrecer un perfil psicométrico exhaustivo de la función sexual que no se limite a una puntuación global:

- Correspondencia con Criterios DSM:** Clasifica los problemas en las dimensiones nosológicas formales de Deseo (frecuencia e interés), Excitación (placer subjetivo y respuesta fisiológica) y Orgasmo (latencia y satisfacción).
- Versiones Específicas por Sexo:** Ajusta los reactivos fisiológicos a la anatomía y respuesta de cada sexo (erección y eyaculación en hombres; lubricación vaginal y clímax en mujeres).
- Direccionalidad Protectiva:** A diferencia de otras escalas donde mayor puntaje indica patología, en el CSFQ-14 una mayor puntuación refleja mejor funcionamiento y plenitud sexual; las puntuaciones bajas alertan de disfunción.

3. LAS 5 DIMENSIONES CLÍNICAS EVALUADAS (14 ÍTEMS)

Dimensión Clínica	Ítems CSFQ	Constructo Neuropsicológico y Fisiológico
1. Deseo: Frecuencia	Ítems 2 y 3	Frecuencia de pensamientos o fantasías sexuales y deseo explícito de tener actividad.
2. Deseo: Interés	Ítems 4, 5 y 6	Interés en iniciar relaciones, disfrute erótico y respuesta a iniciativas de la pareja.
3. Excitación: Placer	Ítems 1, 7 y 8	Grado de deleite y gratificación afectivo-sensorial durante la experiencia sexual.
4. Excitación: Fisiología	Ítems 9, 10 y 11	Erección fácil y suficiente (varones) o lubricación vaginal adecuada (mujeres).
5. Orgasmo / Eyaculación	Ítems 12, 13 y 14	Habilidad para alcanzar el orgasmo, calidad del clímax y sensación de satisfacción.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las baremaciones psicométricas del CSFQ-14 (Keller et al., 2006; Bobes et al., 2000; $N > 900$) demuestran excelencia métrica:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.90 - 0.92	Alta fiabilidad estructural en ambas versiones (masculina y femenina).
Fiabilidad en Dimensiones	Alfa = 0.78 - 0.88	Solidez psicométrica independiente en cada una de las 5 fases del ciclo.
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente r = 0.84 - 0.88	Elevada constancia temporal en intervalos de 2 semanas en controles estables.
Sensibilidad en Depresión	Sensibilidad = 88%	Detección exhaustiva de disfunción premórbida y farmacológica.
Validez Discriminante	Efecto d = 1.25 - 1.60	Separa con precisión sujetos con función sexual sana de pacientes con quejas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Opciones de Respuesta:** Cada ítem se puntúa de 1 a 5 según escala de frecuencia o grado de disfrute (1 = Nunca o muy poco; 5 = Siempre o mucho).
- **Cálculo de la Puntuación Total CSFQ-14:** Suma directa de los 14 ítems:

$$\text{Puntuación Total CSFQ-14} = \sum_{i=1}^{14} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 14 a 70 puntos})$$

- **Direccionalidad Inversa:** Menores puntuaciones indican peor funcionamiento sexual. Las puntuaciones bajas alertan de disfunción patológica.
- **Cálculo de Subescalas:** Permite sumar independientemente Deseo (5 ítems, rango 5-25), Excitación (6 ítems, rango 6-30) y Orgasmo (3 ítems, rango 3-15).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN POR SEXO

Estratificación	Hombres (Total)	Mujeres (Total)	Estado Funcional Sexual (Clayton et al.)
Función Normal / Óptima	>= 48 puntos	>= 42 puntos	Funcionamiento sexual global preservado en todas las fases.
Disfunción Leve	42 a 47 puntos	36 a 41 puntos	Punto de corte clínico alteración leve a moderada.
Disfunción Moderada	35 a 41 puntos	29 a 35 puntos	Afectación notable del deseo o dificultades orgásmicas claras.
Disfunción Severa	< 35 puntos	< 29 puntos	Disfunción severa bloqueo eréctil, anorgasmia o apatía sexual total.

PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS DIFERENCIADOS POR SEXO (CLAYTON ET AL.):

Se diagnostica **Disfunción Sexual Clínica** ante una puntuación total **<= 47 puntos en Hombres** o **<= 41 puntos en Mujeres**. Estos umbrales presentan una sensibilidad del 88% y una especificidad del 83% para identificar a personas que requieren intervención médica o psicológica en su salud sexual.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN EL PERFIL CSFQ-14

PROTOCOLO DE ACCIÓN CLÍNICA BASADO EN SUBESCALAS DEL CSFQ-14:

- **Paso 1 (Administración de la Versión Correspondiente):** Entregar la forma masculina o femenina según corresponda; recalcar que se evalúa la actividad de las últimas 2 semanas.
- **Paso 2 (Análisis Dimensional Focalizado):**
 - *Caída selectiva en Deseo (Ítems 2 a 6):* Típica de trastorno depresivo no resuelto, hipogonadismo o estrés crónico; considerar psicoterapia sexual o bupropión.
 - *Caída selectiva en Excitación Fisiológica (Ítems 9 a 11):* Sospechar causa vascular, metabólica (diabetes, dislipemia) o neuroléptica; valorar fármacos pro-eréctiles (PDE-5i).
 - *Caída selectiva en Orgasmo (Ítems 12 a 14):* Marcador por excelencia de inhibición serotoninérgica inducida por ISRS/IRSN; planificar rotación o reducción de dosis.
- **Paso 3 (Reevaluación Longitudinal):** Repetir el cuestionario a las 4 semanas de cualquier cambio de tratamiento para verificar la recuperación de puntos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: MONITORIZACIÓN DE DISFUNCIÓN COMPLEJA

Identificación: Varón de 44 años, comercial, en tratamiento con Sertralina 100 mg/día por trastorno depresivo mayor recurrente, con remisión anímica casi completa (PHQ-9 = 3). Sin embargo, en la entrevista de seguimiento refiere que “se siente anestesiado en la intimidad y su pareja cree que ya no le atrae”.

Evaluación con CSFQ-14 (Forma Masculina):

- **Puntuación Total CSFQ-14 = 36 / 70 puntos (Disfunción Severa,** netamente por debajo del corte de 47).
- **Desglose por Subescalas:**
 - Deseo / Frecuencia e Interés (ítems 2-6): 15 / 25 puntos (deseo moderadamente presente).
 - Excitación / Placer (ítems 1, 7, 8): 8 / 15 puntos.
 - Excitación Fisiológica / Erección (ítems 9-11): 9 / 15 puntos (dificultad para mantener la rigidez).
 - **Orgasmo / Eyaculación (ítems 12-14): 4 / 15 puntos** (marcado retraso eyaculatorio y clímax débil).

Intervención Psiquiátrica: Al constatar la preservación parcial del deseo pero un colapso en la respuesta orgásmica y eréctil, se pautó la reducción de sertralina a 50 mg/día y se añadió Bupropión 150 mg/día como coadyuvante dopaminérgico.

Reevaluación a los 2 Meses: La puntuación total ascendió a **52 / 70 puntos** (rango normal), normalizándose el tiempo eyaculatorio y restableciéndose la armonía en la pareja.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

PERSONAS SIN PAREJA:

En personas sin actividad en pareja, los ítems de frecuencia coital pueden puntuar bajo artificialmente; evaluar preferentemente masturbación y deseo.

COMORBILIDAD METABÓLICA:

En varones con caída súbita en la subescala de erección, descartar siempre síndrome metabólico, diabetes mellitus oculta o déficit de testosterona.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Clayton, A. H., McGarvey, E. L., & Clavet, G. J. (1997). The Changes in Sexual Functioning Questionnaire (CSFQ): Development, reliability, and validity. *Psychopharmacology Bulletin*, 33(4), 731-745.
2. Keller, A., McGarvey, E. L., & Clayton, A. H. (2006). Reliability and construct validity of the Changes in Sexual Functioning Questionnaire short-form (CSFQ-14). *Journal of Sex & Marital Therapy*, 32(1), 43-65.
3. Bobes, J., et al. (2000). Adaptación española del Cuestionario de Cambios en la Función Sexual (CSFQ). *Actas Españolas de Psiquiatría*, 28(2), 111-120.
4. Clayton, A. H., et al. (2014). Prevalence and treatment of sexual dysfunction in patients with depression. *Current Psychiatry Reports*, 16(11), 513.